ONEMA-POP-055 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Triagem Remota Segura de Dor Abdominal Aguda e Sinais de Alarme

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de triagem remota segura de dor abdominal aguda e

sinais de alarme, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição,

avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Telefone/vídeo, escala de dor, checklist de sinais de alarme. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA;

consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação

clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Localização, início, migração, intensidade, vômitos, febre, gestação, sangramento, síncope, cirurgias prévias. Confirmar

identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar localização e contato do paciente e acompanhante.

02. Caracterizar dor, início, progressão, localização, irradiação e sintomas associados.

03. Pesquisar abdome rígido, dor súbita intensa, síncope, hematêmese/melena, gestação e instabilidade.

04. Na presença de sinais de alarme, orientar SAMU 192 ou serviço de emergência conforme gravidade.

05. Não tranquilizar com base em ausência de febre ou melhora transitória; não fechar diagnóstico remoto.

06. Não orientar automedicação, laxativos ou ingestão forçada quando houver suspeita de abdome agudo.

07. Se quadro sem sinais imediatos de gravidade, estabelecer avaliação presencial em prazo clinicamente apropriado.

08. Documentar sinais positivos/negativos, decisão, orientações e confirmação de encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dor súbita intensa, sangramento, choque, gestação com dor, defesa abdominal: urgência/emergência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Reforçar retorno imediato se piora, vômitos persistentes ou incapacidade de ingerir líquidos.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE NG100 Pancreatitis; NICE NG151 Diverticular disease; abordagem sindrômica sujeita a validação RT | Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.